

ILUMINA — Asociación Sin Fines de Lucro

Departamento de Proyección Social

Subvencionado por Grupo EADES

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA INTENSIVA EN NEUROCIENCIAS APLICADAS AL AULA

"MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO: Neurociencias en el Aula"

*Programa con respaldo académico internacional y convenio municipal,
promovido por el Departamento de Proyección Social de Ilumina (Grupo EADES)*

Convenio con la Municipalidad de San Juan de Miraflores

Junio – Julio 2026 | Modalidad virtual con cierre presencial | 16 horas académicas

Director Académico

Mag. César Escalante Sifuentes

Neuropsicólogo clínico · Psicoterapeuta · Docente · +25 años de experiencia

Máster en Neuropsicología en el ámbito educativo — Universidad Rey Juan Carlos (España)

Co-Facilitador

Lic. Kevin Cubas Verástegui

Psicólogo clínico · Especialista en evaluación e intervención con niños y adolescentes neurodivergentes

Mayo 2026

ÍNDICE

1. Por qué este programa: contexto y urgencia
2. Diferenciación con otros programas de formación especializada
3. Público objetivo y oportunidad territorial
4. Respaldo institucional y convenios
5. Equipo académico
6. Calendario estratégico: fechas, horarios y argumentación
7. Contenido del programa
8. Estructura comercial y paquetes
9. Propuesta de pasantía en Pseres — Grupo EADES
10. Referencias y fuentes

1. POR QUÉ ESTE PROGRAMA: CONTEXTO Y URGENCIA

El Perú enfrenta una crisis silenciosa en la intersección de tres emergencias: alimentaria, educativa y de salud mental. Esta propuesta no nace de la prevención —un escenario ideal—, sino de la urgencia asistencial: los niños con diversos perfiles presentan dificultades y sus docentes no cuentan con herramientas para comprenderlos ni acompañarlos.

La decisión de articular el programa en torno a estas tres dimensiones no es arbitraria. Responde a una cadena causal que la neurociencia, la epidemiología y la investigación educativa han documentado con solidez.

¿Por qué la crisis alimentaria?

El Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria de América del Sur (FAO, SOFI 2024): el 51.7% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto significa que 17.6 millones de peruanos no tienen acceso estable a una alimentación adecuada.

La anemia infantil en menores de 3 años alcanza el 43.7% (ENDES 2024). La evidencia neurocientífica establece que la deficiencia de hierro altera directamente la producción de dopamina y la mielinización de las vías nerviosas, dos procesos esenciales para la atención, la memoria de trabajo y el control de impulsos (Lozoff et al., 2006). Un niño con anemia crónica presenta déficits en las mismas funciones que un niño con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), y sin formación adecuada, el docente no puede distinguir una condición de la otra.

Fuentes: FAO — SOFI 2024 (fao.org/peru). | INEI — ENDES 2024 (gob.pe/inei). | Ivanovic et al. (2001). Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 51(1). | Lozoff, B. et al. (2006). Pediatrics, 118(3).

¿Por qué la crisis de salud mental?

El Estado peruano invierte S/ 20 al año por ciudadano en salud mental, menos del 3% del presupuesto de salud (El Comercio, 2024). El país cuenta con 294 psiquiatras para 33 millones de habitantes —menos de 1 por cada 100,000 personas— (Colegio Médico del Perú, 2025). Las consultas en el Hospital Larco Herrera aumentaron un 400% en tarifas (Conexión Vida, 2025), y los CSMC (Centros de Salud Mental Comunitaria) cubren apenas el 29% de la demanda en Lima (Convoca.pe, 2025). Se estima que 8 de cada 10 peruanos con un trastorno mental no reciben tratamiento. La DIRIS (Dirección de Redes Integradas de Salud) Lima Sur registró más de 182,000 atenciones por salud mental en 2024 (El Comercio, 2024).

Los niños que llegan al aula sin diagnóstico, sin acompañamiento y sin que su docente sepa reconocer qué está sucediendo, son la regla, no la excepción.

Fuentes: El Comercio — inversión per cápita en salud mental (2024). | Colegio Médico del Perú — 294 psiquiatras (2025). | Conexión Vida — tarifas Larco Herrera (2025). | Convoca.pe — brecha CSMC (Centros de Salud Mental Comunitaria), cobertura 29% (2025). | DIRIS Lima Sur — atenciones 2024.

¿Por qué la crisis educativa?

El 92.5% de locales educativos públicos tienen la condición de «inadecuados» y requieren algún tipo de intervención en infraestructura; mientras que el 54.6% debe ser demolido (Infobae/Gestión, 2024). El marco normativo exige inclusión (R.M. N° 447-2020-MINEDU: mínimo 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad), pero solo el 17.7% de docentes ha recibido capacitación en enfoque inclusivo

(CONADIS, 2023) y los equipos de SAE (Servicio de Apoyo Educativo) cubren apenas el 45.06% de instituciones con estudiantes con discapacidad (CONADIS, 2024). La R.M. N° 556-2014-MINEDU establece un máximo de 30 estudiantes por aula en educación básica; sin embargo, la realidad en muchas instituciones educativas de zonas urbanas supera ampliamente esta cifra.

Fuentes: Infobae Perú (2024). | Gestión (2024). | CONADIS — Observatorio Nacional de Discapacidad, OP4 Educación Inclusiva: 17.7% capacitación docente (2023) y 45.06% cobertura SAE (2024). | R.M. N° 447-2020-MINEDU. | R.M. N° 556-2014-MINEDU.

La intersección de estas tres crisis

Estas tres dimensiones no operan de manera aislada. El niño con anemia presenta déficits en las mismas funciones ejecutivas que el niño con TDAH. El docente sin formación en neurodivergencia confunde ambas condiciones. El sistema de salud no tiene capacidad para evaluar a todos. Y el sistema educativo exige inclusión sin ofrecer herramientas. Este programa nace para intervenir precisamente en ese punto ciego.

2. DIFERENCIACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Mientras la competencia ofrece talleres genéricos sobre adaptaciones curriculares o DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), nuestro programa se distingue en cinco ejes concretos:

- **Neurociencia aplicada al aula:** El programa traduce conceptos neurocientíficos en estrategias concretas para comprender y acompañar a estudiantes con TDAH, TEA (Trastorno del Espectro Autista) y otros perfiles neurodivergentes dentro del aula real, no del aula ideal.
- **Diseñado para la realidad educativa peruana:** La propuesta responde a contextos de aulas heterogéneas, limitada cobertura SAE (Servicio de Apoyo Educativo), escasa formación especializada y estudiantes que muchas veces llegan al aula con hambre, anemia o sin diagnóstico.
- **Mirada interdisciplinaria del comportamiento infantil:** En un contexto donde el 43.7% de menores de 3 años presenta anemia (ENDES 2024), el programa aborda cómo factores neurobiológicos, nutricionales y ambientales se confunden con trastornos del neurodesarrollo, y qué puede hacer el docente para diferenciarlos.
- **Conducción clínica especializada:** El programa es dirigido por el Mag. César Escalante Sifuentes, neuropsicólogo clínico con más de 25 años de experiencia, y el Lic. Kevin Cubas Verástegui, psicólogo clínico especializado en evaluación e intervención con niños y adolescents.
- **Pasantía de observación neuroinformada:** Los participantes con mejor desempeño podrán acceder a una experiencia de observación guiada en procesos reales de evaluación e intervención en el centro Pseres, perteneciente al Grupo EADES, una oportunidad única en este segmento formativo.

3. PÚBLICO OBJETIVO Y OPORTUNIDAD TERRITORIAL

San Juan de Miraflores tiene una población estimada de 433,709 habitantes (INEI, proyección 2025) y pertenece a la jurisdicción de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) 01 y la DIRIS Lima Sur. Es un distrito de clase media-baja y baja, con bolsones de pobreza especialmente en las zonas altas (Pamplona Alta, Pampas de San Juan), donde la intersección entre desnutrición infantil, déficit de servicios de salud mental y precariedad educativa es más aguda.

Perfil del participante:

Docentes de colegios nacionales (UGEL 01)

Maestros de inicial, primaria y secundaria que enfrentan aulas con estudiantes neurodivergentes sin formación especializada. Aunque el sistema exige inclusión, solo el 17.7% de docentes ha sido capacitado bajo el enfoque inclusivo (CONADIS, 2023). La mayoría trabaja sin apoyo del SAE y sin acceso a evaluación neuropsicológica para sus alumnos.

Docentes de colegios privados pequeños

Profesores de instituciones particulares con recursos limitados que no pueden costear capacitaciones corporativas. Muchos trabajan en aulas con alta carga estudiantil, múltiples funciones administrativas y ninguna formación específica en neurodivergencia.

Según la Encuesta Nacional a Docentes (ENDO, MINEDU 2018), aproximadamente 69,000 docentes a nivel nacional no cuentan con acceso a computadora o laptop y 136,000 no tienen internet en casa. Una encuesta más reciente (ENDO, MINEDU 2021) evidenció que las dificultades de conectividad y adaptación tecnológica continúan incluso después de la educación virtual postpandemia. Con una estrategia de bajo consumo de datos y acceso desde dispositivos móviles, el programa virtual es viable para este perfil.

Fuente: CONADIS (2023). | MINEDU — ENDO 2018. | MINEDU — Plan de Cierre de Brecha Digital.

Padres y madres de familia

Familias que han recibido un diagnóstico para su hijo o que sospechan dificultades, y que necesitan comprender qué está sucediendo desde la ciencia, no desde el mito o el prejuicio. En SJM, estas familias enfrentan un sistema de salud mental colapsado: los CSMC cubren apenas el 29% de la demanda en Lima y las tarifas del Hospital Larco Herrera aumentaron un 400% (Convoca.pe, 2025; Conexión Vida, 2025).

Datos clave del contexto educativo-inclusivo:

- **Dato 1 — Matrícula de estudiantes con discapacidad:** A septiembre de 2023, más de 83,000 estudiantes con discapacidad están matriculados en educación básica en el Perú. De estos, 63,191 están en Educación Básica Regular. Fuente: MINEDU — «Más de 80 mil estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema educativo» (2023).
- **Dato 2 — Solo el 17.7% de docentes capacitados en inclusión:** Para el año 2023, únicamente el 17.7% de docentes de instituciones educativas fue capacitado bajo el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Fuente: Observatorio Nacional de Discapacidad — CONADIS, Política OP4: Educación Inclusiva (2023).
- **Dato 3 — Cobertura SAE llega solo al 45%:** En 2024, los equipos SAE (antes SAANEE — Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades Educativas Especiales) brindaron servicio a solo el 45.06% de instituciones educativas públicas con estudiantes con discapacidad. Fuente: CONADIS, Política OP4 (2024).

- **Dato 4 — Vacantes obligatorias por ley:** Según la R.M. N° 447-2020-MINEDU, toda institución educativa pública y privada debe reservar como mínimo 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve o moderada. Fuente: R.M. N° 447-2020-MINEDU.
- **Dato 5 — Lo que dicen las familias:** El Informe Defensorial N° 183 (2019) encontró que los principales problemas reportados son la falta de docentes especialistas y la ausencia de capacitación para la atención de la diversidad. Fuentes: Defensoría del Pueblo — Informe Defensorial N° 183 m(2019). | Defensoría del Pueblo — Supervisión de educación inclusiva (2024).

4. RESPALDO INSTITUCIONAL Y CONVENIOS

Este programa cuenta con respaldo académico internacional y convenio municipal, promovido por el Departamento de Proyección Social de Ilumina (Grupo EADES). A continuación, se describen las instituciones que respaldan esta formación.

Respaldo Internacional

Instituto Raimon Gaja (IRG) — Barcelona, España

Institución de referencia en Europa en formación en psicología clínica, neurociencia y desarrollo humano, con más de cuatro décadas de trayectoria formando profesionales de la salud mental en España y Latinoamérica. El IRG es reconocido por su enfoque integrador entre neurociencia y práctica clínica. Grupo EADES mantiene un convenio de colaboración académica con el IRG, lo que permite articular estándares formativos internacionales con la realidad profesional peruana.

International Association of Therapists (IAOTH) — Reino Unido

Organización internacional con sede en el Reino Unido dedicada a la acreditación de terapeutas y profesionales de la salud a nivel global. La IAOTH establece estándares de calidad y ética profesional reconocidos internacionalmente. Grupo EADES es Organización Acreditada por la IAOTH, lo que certifica el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en sus programas de formación y servicios clínicos.

European Association of Applied Psychology (EAAP) — Europa

Asociación europea dedicada a la promoción de la psicología aplicada bajo el lema «Psychology — accessible, practical, useful» (Psicología — accesible, práctica, útil). La EAAP promueve la aplicación de la psicología basada en evidencia en contextos educativos, organizacionales y de salud. Su respaldo refuerza el enfoque aplicado y científico del programa.

Respaldo Nacional

Grupo EADES

Grupo empresarial peruano que integra servicios de psicoterapia, psicoeducación, formación especializada e investigación clínica. Fundado y dirigido por el Mag. César Escalante Sifuentes, articula las operaciones de EADES, Pseres, Ilumina y los convenios internacionales. Entidad financiadora y respaldo corporativo del programa.

Ilumina — Asociación Sin Fines de Lucro

Brazo de proyección social del Grupo EADES. Ilumina canaliza el compromiso social del grupo hacia comunidades con acceso limitado a servicios de salud mental y formación especializada. Es la entidad promotora de este programa, garantizando que la formación llegue a docentes y familias que más la necesitan.

Pseres — Psicoterapia y Psicoeducación

Centro clínico especializado en evaluación e intervención neuropsicológica con niños, adolescentes y familias, ubicado en Miraflores. Su equipo trabaja de forma coordinada con instituciones educativas, lo que permite una lectura clínica informada por la realidad del aula. Pseres es la sede de la pasantía de observación neuroinformada que se ofrece a los participantes destacados del programa, conectando la formación teórica con la práctica clínica real.

Municipalidad de San Juan de Miraflores

Convenio institucional que ancla el programa al territorio y facilita la convocatoria entre docentes, instituciones educativas y familias del distrito. Este convenio garantiza la pertinencia territorial del programa y su articulación con las necesidades de la comunidad educativa local.

5. EQUIPO ACADÉMICO

Mag. César Escalante Sifuentes — Director Académico

CPSP N° 29611

Psicólogo clínico y psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia en salud mental y 16 años de ejercicio docente en el sistema educativo peruano. Magíster en Neuropsicología en el ámbito educativo por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Formación complementaria en la Université Sorbonne Nouvelle (Francia) y la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (Argentina). Especializado en terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica familiar y psicoanálisis.

Su trayectoria integra la mirada clínica con el conocimiento directo del aula: ha trabajado como docente de aula y como psicólogo del Departamento de Bienestar Psicopedagógico de la Universidad del Pacífico (2019-2020). Colaborador de artículos de salud en diarios del Grupo La República. Fundador y Director General del Grupo EADES. Esta doble experiencia —clínica y pedagógica— fundamenta el enfoque práctico del programa.

Lic. Kevin Cubas Verástegui — Co-Facilitador

CPSP N° 66725

Psicólogo clínico especializado en evaluación psicológica, diferenciación de cuadros psicopatológicos y aplicación de instrumentos de diagnóstico en población infantil y adolescente.

Cuenta con experiencia directa en acompañamiento terapéutico de niños y adolescentes con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) utilizando

técnicas de la terapia cognitivo-conductual, aporta al programa una mirada clínica actualizada y cercana a la realidad de los niños y adolescentes neurodivergentes. Su formación en técnicas de entrevista, diagnóstico e intervención en psicología de adultos, niños y adolescentes con TEA y TDAH fortalece el componente práctico de detección y comunicación con familias.

Actualmente se desempeña como gestor de proyectos de capacitación y evaluación psicológica, combinando la práctica clínica con la formación de profesionales de la salud y la educación.

6. CALENDARIO ESTRATÉGICO

Fechas y horarios — Junio-Julio 2026

Módulo	Clase	Fecha	Horario	Modalidad
I	Clase 1	Martes 23 de junio	7:30 – 9:30 p.m.	Virtual
I	Clase 2	Jueves 25 de junio	7:30 – 9:30 p.m.	Virtual
II	Clase 3	Martes 30 de junio	10:00 a.m. – 12:00 p.m.	Virtual
II	Clase 4	Jueves 02 de julio	7:30 – 9:30 p.m.	Virtual
III	Clase 5	Martes 07 de julio	7:30 – 9:30 p.m.	Virtual
III	Clase 6	Jueves 09 de julio	7:30 – 9:30 p.m.	Virtual
IV	Clase Magistral de Cierre	Sábado 11 de julio	Turno 1: 09:00 – 10:30 a.m. Turno 2: 11:00 a.m. – 12:30 p.m.	Presencial

Total: 18 horas académicas (HA) de formación sincrónica

- 16 HA clases virtuales
- 2 HA clase magistral de clausura presencial

Distribución de la carga formativa (18 HA)

- Formación teórica y resolución de consultas: 12 HA
- Formación práctica-aplicada (talleres y ejercicios vivenciales): 6 HA

Argumentación estratégica de las fechas y horarios:

¿Por qué martes, jueves y sábado?

La distribución martes-jueves (y sábado como refuerzo) se fundamenta en la práctica espaciada (spaced practice): intervalos de 48 horas entre sesiones optimizan la consolidación de aprendizajes en memoria a largo plazo (Cepeda et al., 2006, 2008). El sábado permite una sesión de mayor profundidad sin las limitaciones del horario nocturno.

¿Por qué de 7:30 a 9:30 p.m.?

La jornada laboral de un docente en Lima termina entre las 3:00 y las 5:00 p.m. (turno mañana) o a las 6:30 p.m. (turno tarde). El horario de 7:30 p.m. permite que incluso los docentes de turno tarde dispongan

de tiempo para trasladarse, cenar y conectarse. Es un horario coherente con los principios de la andragogía (Knowles, 1980): el adulto aprende mejor cuando la formación se adapta a sus restricciones reales de tiempo y responsabilidad.

Fuentes: Cepeda, N.J. et al. (2006). Review of Educational Research, 76(3). | Cepeda, N.J. et al. (2008). Psychological Science, 19(11). | Knowles, M.S. (1980). The Modern Practice of Adult Education.

7. CONTENIDO DEL PROGRAMA

CICLO: «MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO: Neurociencias en el Aula»

MÓDULO I: «NEUROCIENCIA, NUTRICIÓN Y APRENDIZAJE: EL CEREBRO QUE NO RECIBE LO QUE NECESITA»

Neurociencia del aprendizaje en contextos de pobreza y malnutrición

Clase 1 — Martes 23 de junio (7:30 – 9:30 p.m.) — Virtual

Nutrición y neurodesarrollo: cómo la deficiencia de hierro afecta la atención, la memoria y la conducta en el aula

- Qué le ocurre al cerebro de un niño con anemia crónica y por qué sus conductas en clase se parecen (y se confunden) con las de un niño con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).
- Cómo distinguir en el aula un problema de nutrición de un trastorno del neurodesarrollo sin necesidad de una evaluación especializada que probablemente no va a llegar.
- Guía de observación conductual para docentes: 8 señales que diferencian déficit nutricional de TDAH en el aula.
- **Taller:** Análisis guiado de caso real — un niño que «no presta atención» en una I.E. de Pamplona Alta. Los participantes aplican la guía de observación, identifican indicadores y construyen una hipótesis funcional con retroalimentación del Mag. Escalante.

Clase 2 — Jueves 25 de junio (7:30 – 9:30 p.m.) — Virtual

Estrategias de aula cuando no hay SAE (Servicio de Apoyo Educativo), no hay psicólogo y el apoyo familiar es limitado

- 5 ajustes concretos de organización de aula que mejoran atención y memoria de trabajo con cero presupuesto (distribución de asientos, señalización visual con material reciclado, rutinas de activación en 90 segundos).
- Cómo manejar un aula de 35+ alumnos donde al menos 4 tienen perfiles neurodivergentes no diagnosticados y 10 tienen riesgo nutricional: protocolo de agrupamiento funcional.
- Actividades breves de 3 minutos entre tareas para reactivar la atención sostenida, la flexibilidad ante cambios de actividad y la capacidad de planificación — basadas en evidencia, adaptadas a aulas sin materiales.
- **Taller:** Diseño del plan de aula diferenciado. A partir de un modelo trabajado en sesión, cada participante define el perfil de su alumno, los ajustes que aplicará y sus indicadores de seguimiento. Se entrega plantilla para desarrollar durante la semana.

MÓDULO II: «DETECCIÓN FUNCIONAL EN EL AULA: MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO QUE NO LLEGA»

Detección funcional de TDAH, TEA (Trastorno del Espectro Autista), dislexia y altas capacidades en contextos donde el diagnóstico no existe

Clase 3 — Martes 30 de junio (07:30 p.m. – 09:30 p.m.) — Virtual

Observación e identificación en el aula: hasta dónde llega el docente y desde dónde se necesita al especialista

- Perfil observable en aula de TDAH, TEA, dislexia y altas capacidades: qué conductas buscar, en qué momentos del día escolar aparecen y por qué el recreo revela más que un examen.
- Por qué los criterios clínicos del DSM-5 no son suficientes para detectar en contextos como Pamplona Alta: la diferencia entre el manual y la observación funcional en territorio.
- Herramienta de identificación docente: ficha de observación de 15 ítems que se puede aplicar en una semana sin interrumpir la programación curricular.
- **Taller:** Ejercicio de observación sobre viñetas clínicas narradas por el Mag. Escalante. Los participantes aplican la ficha de identificación, comparten sus lecturas y las contrastan con el análisis del neuropsicólogo. Se cierra con la construcción colectiva de una ruta de derivación realista para SJM y Lima Sur.

Clase 4 — Jueves 02 de julio (7:30 – 9:30 p.m.) — Virtual

Documentación y comunicación: cómo registrar lo observado y cómo transmitirlo a familias y especialistas

- Cómo redactar un informe de observación conductual que un neurólogo o psicólogo pueda usar como insumo de evaluación — formato paso a paso.
- Qué lenguaje usar y qué lenguaje evitar al comunicar a los padres que su hijo presenta un perfil de aprendizaje diferente.
- Registro de derivación y seguimiento: plantilla para que el docente mantenga la trazabilidad del caso aunque cambie de sección o de año.
- **Taller:** El Mag. Escalante asume el rol de padre/madre resistente y presenta un escenario paso a paso. En cada momento clave, el grupo decide colectivamente cómo responder: qué decir, qué evitar, cómo reconducir la conversación. Se trabajan dos escenarios con perfiles de familia distintos.

MÓDULO III: «INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DIFERENCIADA EN CONTEXTOS DE RECURSOS LIMITADOS»

Intervención pedagógica diferenciada sin presupuesto y sin apoyo especializado

Clase 5 — Martes 07 de julio (7:30 – 9:30 p.m.) — Virtual

Adaptaciones curriculares accesibles: qué modificar, cómo implementarlo y en cuánto tiempo

- Diferencia entre adaptación curricular significativa y no significativa: cuál puede realizar el docente de forma autónoma y cuál requiere respaldo institucional (y cómo gestionarlo).

- 6 modificaciones de evaluación aplicables de inmediato: tiempo extendido, evaluación oral, fragmentación de consignas, reducción de ítems, apoyo visual, rúbrica diferenciada — con ejemplos por área curricular (comunicación, matemática, ciencia).
- Cómo adaptar una sesión de aprendizaje de 90 minutos para que funcione simultáneamente para el alumno neurotípico, el alumno con TDAH y el alumno con dislexia — sin triplicar la carga de trabajo.
- **Taller:** Cada participante toma una sesión de su programación curricular actual y la adapta en vivo durante la sesión, con retroalimentación directa del Mag. Escalante y del grupo.

Clase 6 — Jueves 09 de julio (7:30 – 9:30 p.m.) — Virtual

Perfiles invisibles, bienestar docente y plan de continuidad post-seminario

- Perfiles que no activan ninguna alerta: TDAH predominantemente inatento (desconexión silenciosa, errores por omisión), autismo enmascarado (imitación social rígida, caída en contextos no estructurados), dislexia compensada (discrepancia entre capacidad oral y escrita) y altas capacidades con bajo rendimiento (confundido con desmotivación o problema de aprendizaje). Ajustes a las herramientas de observación del Módulo II para detectar lo que el sistema no está viendo.
- Desgaste profesional y neurodivergencia: por qué atender perfiles diferentes sin formación ni acompañamiento genera agotamiento y qué dice la evidencia sobre cómo prevenirlo.
- Construcción de red de apoyo entre docentes de la misma zona: protocolo de acompañamiento entre pares que no depende de la UGEL ni de la dirección.
- Plan de continuidad: cronograma de implementación de 8 semanas para aplicar lo aprendido de forma progresiva y sostenida.
- **Taller:** Diseño del plan de continuidad individual y formalización de la red de apoyo por zona. Cada participante define sus compromisos, sus pares de acompañamiento y su cronograma de implementación. Se entrega el kit docente completo (guías de observación, fichas, plantillas, rutas de derivación) en formato digital listo para imprimir.

MÓDULO IV: «EL RECURSO MÁS LIMITADO ERES TÚ: NEUROCIENCIA DEL DOCENTE EN CONTEXTOS DE SOBRECARGA»

Qué hacer con el propio cerebro para poder aplicar lo aprendido

Clase 7: Clase Magistral de Cierre — Sábado 11 de julio (09:00 – 10:30 a.m. y 11:00 – 12:30 p.m.) — Presencial

- Protocolo de implementación escalonada: qué herramientas del programa aplicar primero, cuáles pueden esperar y cómo distribuirlas en un cronograma de 8 semanas con un solo foco por quincena — diseñado para contextos de alta carga laboral y sin acompañamiento institucional.
- Técnicas de recuperación cognitiva entre bloques de clase: intervenciones breves con respaldo empírico que restauran la capacidad atencional del docente y permiten mantener la calidad de observación funcional a lo largo de toda la jornada.
- Fatiga decisional y observación en aula: la toma sostenida de decisiones deteriora la calidad del juicio pedagógico hacia el final de la jornada. Se trabajan dos estrategias: en qué momento del día aplicar

las fichas de observación para que sean confiables, y cómo reducir la carga decisional en aula mediante un sistema de señales mínimas.

- ¿Y si el neurodivergente eres tú? Muchos docentes son TDAH, disléxicos o de altas capacidades no diagnosticados. Se entregan criterios para identificar si el propio perfil cognitivo está incidiendo en la práctica docente, y qué ajustes aplicar desde las neurociencias.
- Árbol de decisión docente: compilación de las herramientas del programa en una secuencia de uso — qué herramienta aplicar ante qué situación, en qué orden, y en qué punto derivar. Una guía de referencia rápida para el aula.

8. ESTRUCTURA COMERCIAL Y PAQUETES

Propuesta de precios — Programa completo junio-julio 2026

El programa puede adquirirse por módulos individuales o como paquete completo. La adquisición del paquete completo incluye la posibilidad de acceder a la pasantía y la certificación con respaldo internacional y nacional.

PAQUETE	INCLUYE	INVERSIÓN
PAQUETE VIRTUAL (Recomendado como base)	3 módulos virtuales (6 sesiones de 2 horas) + posibilidad de acceder a la pasantía + Materiales digitales + Certificación virtual	S/ 150
PAQUETE VIRTUAL + CERTIFICACIÓN FÍSICA	Todo lo anterior + Certificado impreso con respaldo internacional (recojo en las instalaciones del Grupo EADES)	S/ 160
PAQUETE COMPLETO (Mejor valor)	Todo lo anterior + 1 Clase magistral presencial de cierre en auditorio del Grupo EADES + Networking profesional + Certificado impreso con respaldo internacional (entrega en mano)	S/ 190
SEMINARIO INDIVIDUAL	1 módulo (2 sesiones virtuales)	S/ 50

9. PROPUESTA DE PASANTÍA EN PSERES — GRUPO EADES

Concepto: «Pasantía de Observación Neuroinformada»

Una experiencia formativa de inmersión en el centro Pseres de Miraflores (Grupo EADES), donde los participantes seleccionados podrán observar y participar guiadamente en sesiones reales de evaluación e intervención neuropsicológica con niños y adolescentes, así como de acompañamiento familiar.

Estructura propuesta:

- Duración: 3 jornadas de 3 horas cada una (9 horas total), a realizarse en julio 2026.
- Sede: Centro Pseres, Miraflores.
- Cupos: Máximo 4 participantes.
- Costo: Gratuito para los seleccionados.
- Certificación adicional: Constancia de pasantía con aval de Pseres y respaldo internacional.

Actividades de la pasantía:

- Observación guiada de una sesión de evaluación neuropsicológica infantil/psicoeducativa (con consentimiento del caso).
- Participación en un análisis de caso clínico conducido por el Mag. Escalante.
- Observación de una sesión psicoeducativa con un niño neurodivergente y/o su familia.
- Taller práctico de diseño de estrategias de intervención para un caso real.
- Mentoría grupal: preguntas directas al equipo clínico de Pseres sobre casos y desafíos profesionales.

Criterios de selección de pasantes:

1. Asistencia completa (requisito eliminatorio): Haber asistido a las 5 clases virtuales y a la clase magistral de clausura. Solo se considerarán participantes con asistencia al 100%.
2. Participación activa durante los seminarios (30%): Se evaluará la calidad de las intervenciones en las sesiones virtuales: preguntas formuladas, aportes compartidos, participación en los talleres prácticos.
3. Proyecto aplicado (70%): Al finalizar el Módulo III, cada participante deberá entregar un «Proyecto de Inclusión Neuroinformada» que consiste en diseñar una intervención para un caso real (anonimizado) de su propia aula o consulta.

También tendrán como opción alternativa elaborar un ensayo reflexivo: un escrito breve (máximo 500 palabras) respondiendo: «¿Cómo ha cambiado mi forma de comprender y acompañar a una persona neurodivergente después de este programa?».

10. REFERENCIAS Y FUENTES

- Baumeister, R.F. et al. (1998). «Ego depletion: Is the active self a limited resource?». *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252-1265.
- Berman, M.G. et al. (2008). «The cognitive benefits of interacting with nature». *Psychological Science*, 19(12), 1207-1212.
- Cepeda, N.J. et al. (2006). «Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis». *Review of Educational Research*, 76(3), 354-380.
- Cepeda, N.J. et al. (2008). «Spacing Effects in Learning». *Psychological Science*, 19(11), 1095-1102.

Conexión Vida (2025). «Aumento del 400% en tarifas del Hospital Larco Herrera».
 Convoca.pe (2025). «Perú necesita casi 400 centros comunitarios para cubrir brecha de atención en salud mental».
 Defensoría del Pueblo (2019). Informe Defensorial N° 183: El Derecho a la Educación Inclusiva.
 Defensoría del Pueblo (2024). Supervisión de educación inclusiva y violencia escolar.
 El Comercio (2024). «El Estado invierte 20 soles al año en cada peruano en salud mental».
 El Comercio (2024). «¿Qué distritos de Lima registran más atenciones por salud mental?».
 FAO (2024). SOFI 2024: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.
 Gestión (2024). «El 54.6% de colegios públicos están en muy mal estado y deben ser demolidos».
 INEI (2025). ENDES 2024: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
 Infobae Perú (2024). «Más del 92% de colegios necesita intervención en su infraestructura».
 Infobae Perú (2025). «Anemia infantil en menores de 3 años subió a 43.7%».
 Ivanovic, D. et al. (2001). Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 51(1).
 Kaplan, S. (1995). «The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework». Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182.
 Knowles, M.S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. Cambridge.
 Lozoff, B. et al. (2006). «Long-lasting neural and behavioral effects of iron deficiency in infancy». Nutrition Reviews, 64(5).
 MINEDU — ENDO: Encuesta Nacional a Docentes. Plan de Cierre de Brecha Digital.
 MINEDU (2020). R.M. N° 447-2020-MINEDU: Reserva de vacantes para estudiantes con discapacidad.
 MINEDU (2023). Matrícula de estudiantes con discapacidad en educación básica.
 Mönckeberg, F. & Albino, A. (2004). «Desnutrición y déficit cognitivo en contexto de pobreza». CONICET.
 Observatorio Nacional de Discapacidad — CONADIS (2023-2024). Política OP4: Educación Inclusiva.